جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : غاليه صلاح الدين فرحات عطيه
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المعصره **العنوان :** المعصرة المحطه
رقم البطاقة : 26607271500203 **رقم التليفون :** 01124887003 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-07-1966 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام رنين علي الفقرات العنقيه والظهريه بالصبغه [11112] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: غاليه صلاح الدين فرحات عطيه
National ID: 26607271500203

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced MRI of cervical and thoracic spine

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه
صلاح الدين فرحات عطيه
٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه
المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

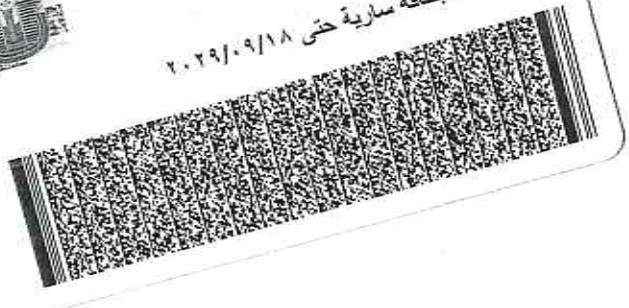
١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559





٢٠٣٠٠١٥٠٧٢٧٢٦٦٠ ٢٠٢٢/٠٩
رية منزل
انثى
١ مسلمة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات **Age:**66 years **Sex:** female
Request type:مبادره **Sub request type:**
Hospital no: **Pathology no.:**745-2026
Department:صحه مرأه **Date of result:**8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني **Date of biopsy:**30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy **I.D. Number:**26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه

صلاح الدين فرحات عطيه

٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه

المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559



٢٠٣٠٠٢١٥٠٧٢٧٢٦٦

رية منزل

٢٠٢٢/٠٩

أنثى

١

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات | Age:66 years | Sex: female
Request type:مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:745-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني | Date of biopsy:30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

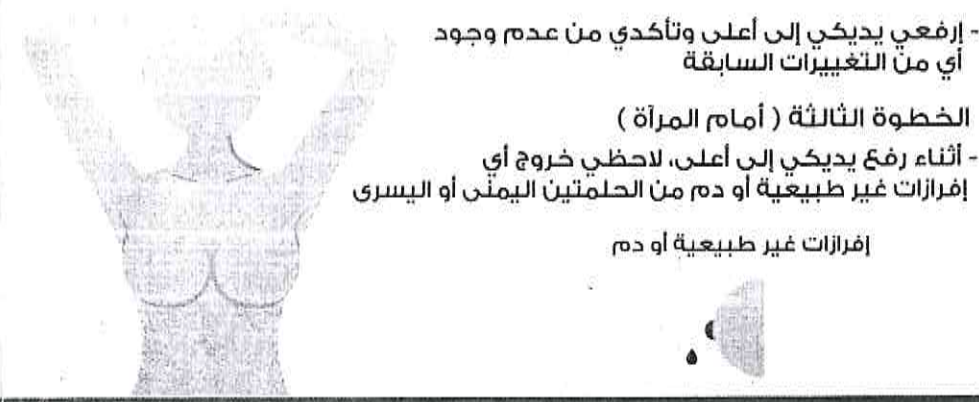


الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى



- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

الخطوة الرابعة (على السرير)

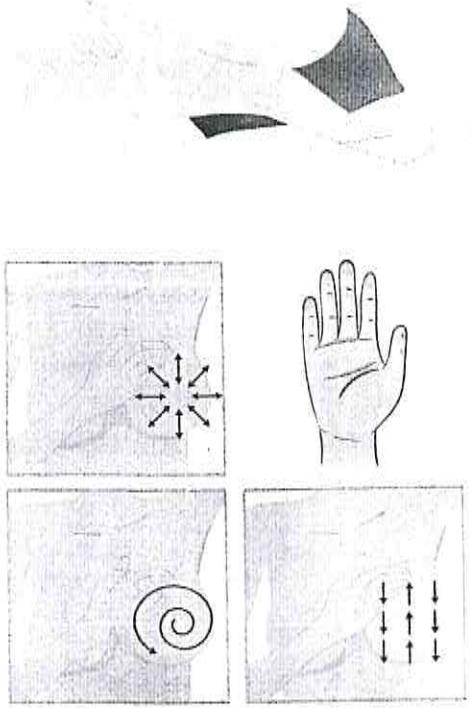
- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

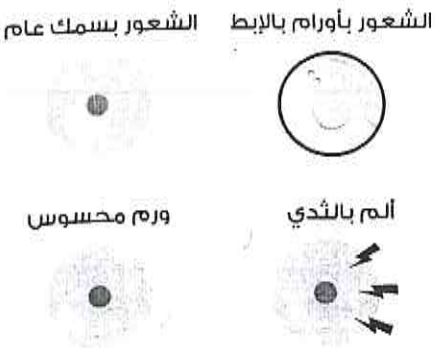
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

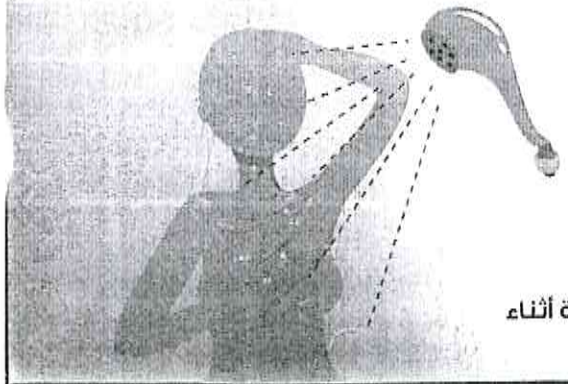


- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.



- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه

صلاح الدين فرحات عطيه

٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه

المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559



٢٠٣٠٠٢١٥٠٧٢٧٢٦٦

رية منزل

٢٠٢٢/٠٩

أنثى

١

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات | Age:66 years | Sex: female
Request type:مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:745-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني | Date of biopsy:30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

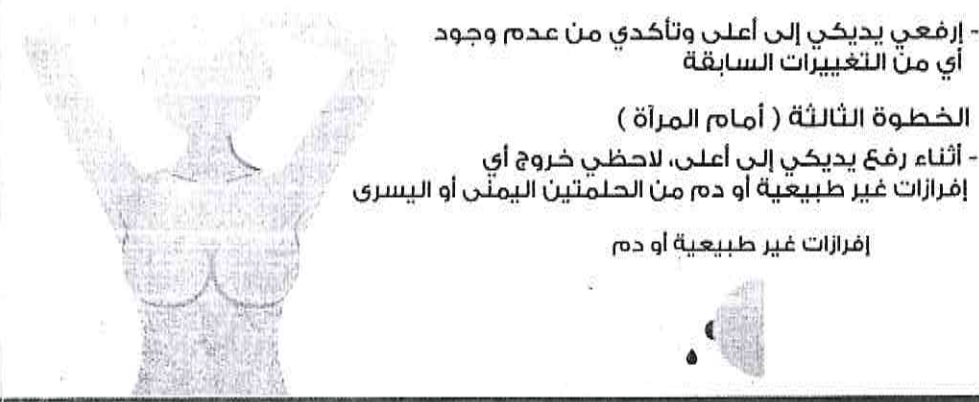


الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى



- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

الخطوة الرابعة (على السرير)

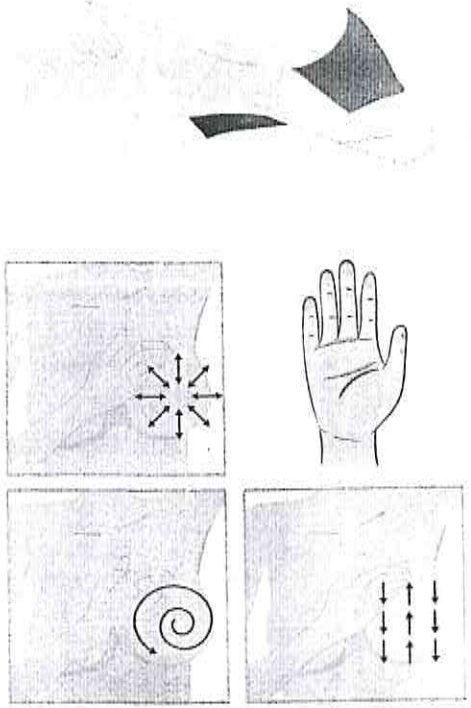
- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

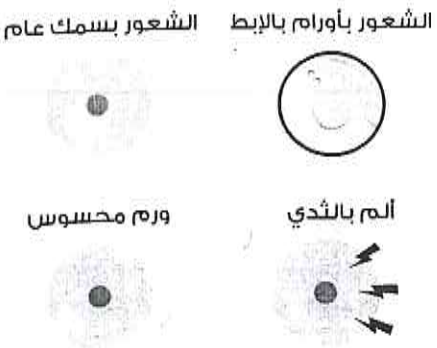
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

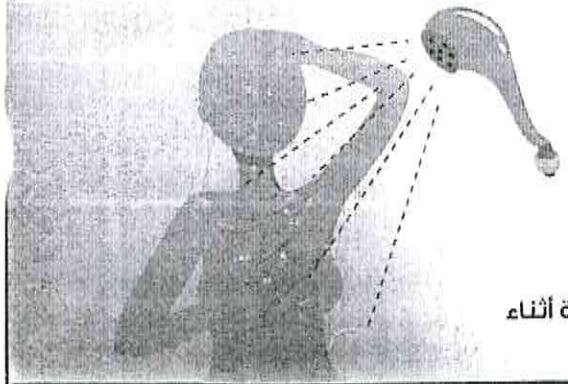


- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.



- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه

صلاح الدين فرحات عطيه

٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه

المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559



٢٠٣٠٠٢١٥٠٧٢٧٢٦٦

رية منزل

٢٠٢٢/٠٩

أنثى

١

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات | Age:66 years | Sex: female
Request type:مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:745-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني | Date of biopsy:30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

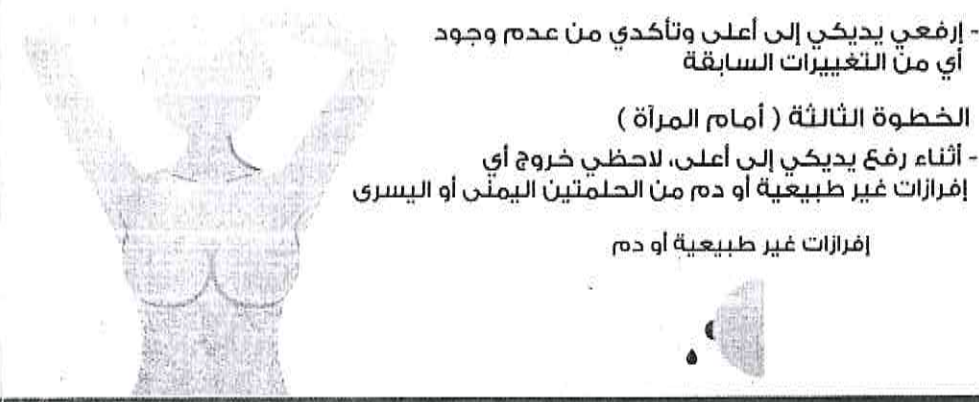


الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى



- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

الخطوة الرابعة (على السرير)

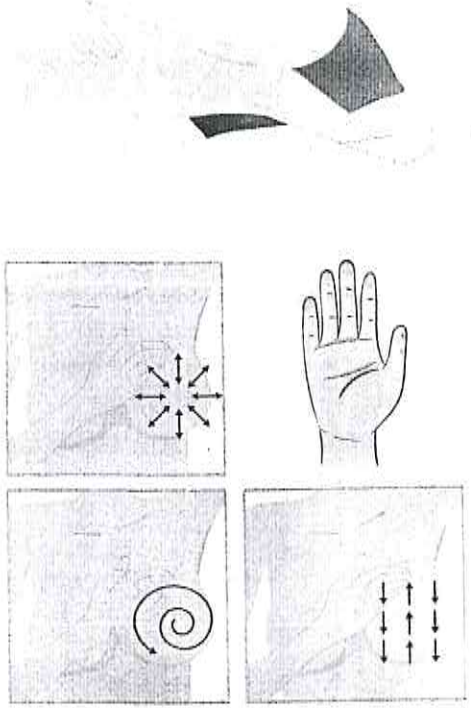
- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

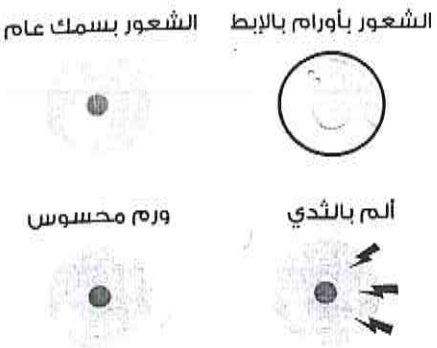
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

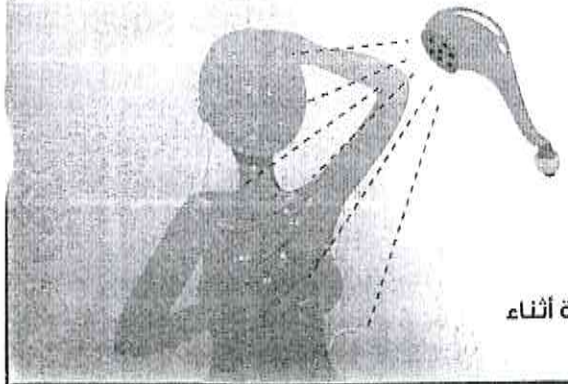


- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.



- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه

صلاح الدين فرحات عطيه

٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه

المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559



٢٠٣٠٠٢١٥٠٧٢٧٢٦٦

رية منزل

٢٠٢٢/٠٩

أنثى

١

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات | Age:66 years | Sex: female
Request type:مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:745-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني | Date of biopsy:30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

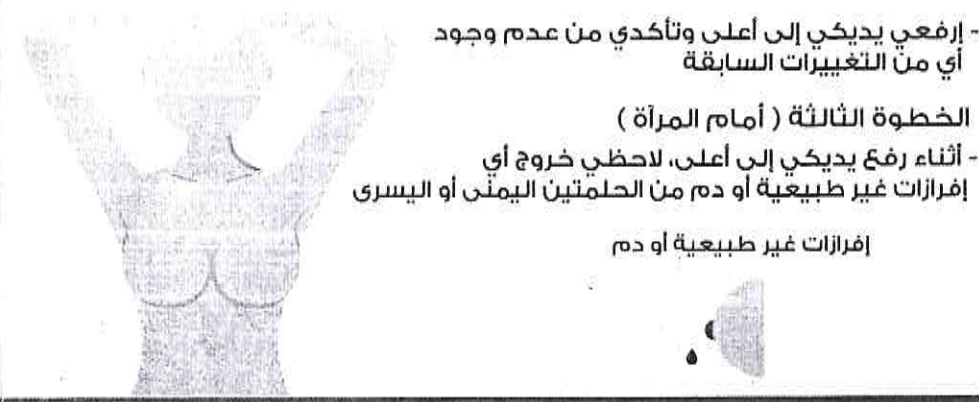


الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى



- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

الخطوة الرابعة (على السرير)

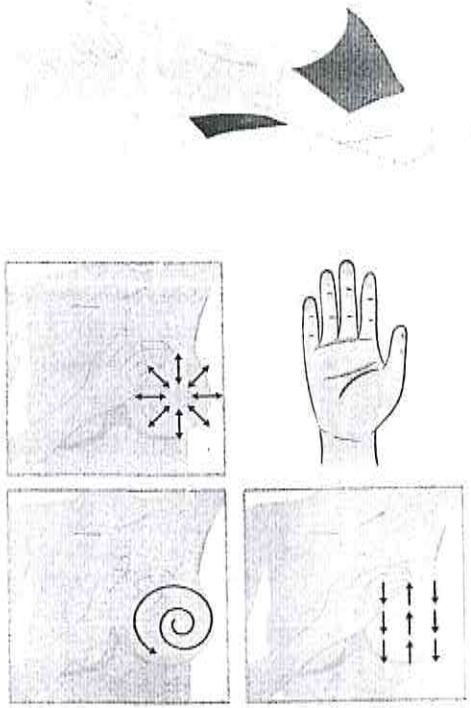
- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

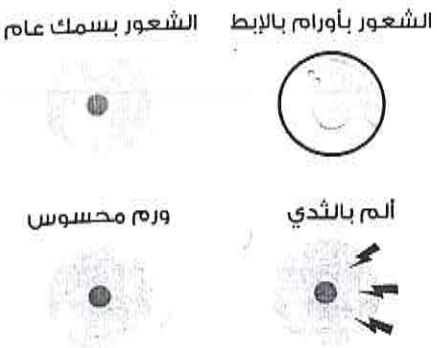
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

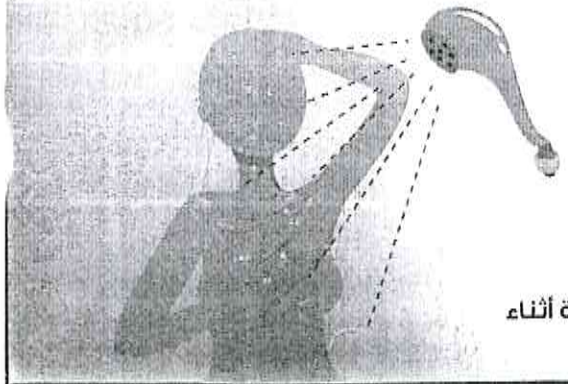


- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.



- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



غاليه

صلاح الدين فرحات عطيه

٣٤ش عبدالجوادالسيد-المعصره المحطه

المعصرة - القاهره

٢٦٦٠٧٢٧١٥٠٠٢٠٣

١٩٦٦/٠٧/٢٧

J01931559



٢٠٣٠٠٢١٥٠٧٢٧٢٦٦

رية منزل

٢٠٢٢/٠٩

أنثى

١

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١٨



NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات | Age:66 years | Sex: female
Request type:مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:745-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:8/8/2026
Referred by:د/ايمان عوني | Date of biopsy:30/7/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:26607271500203
Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology:
multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malignant growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result;
ER: Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).
PR: Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)Her2 Positive
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

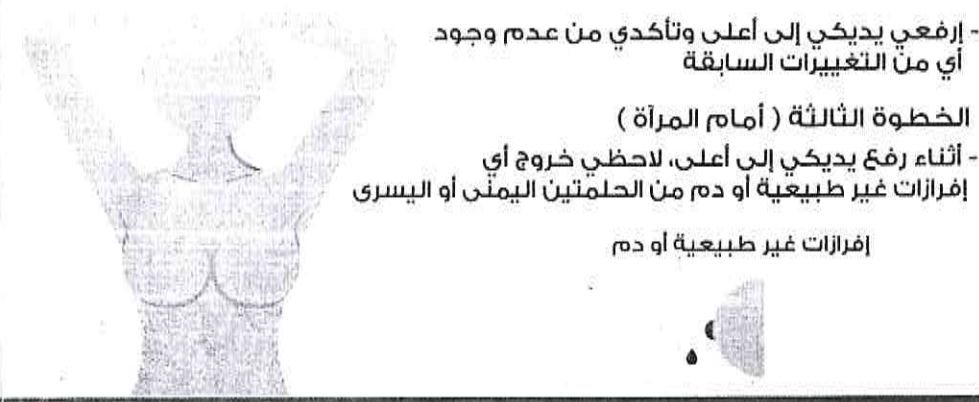


الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى



- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

الخطوة الرابعة (على السرير)

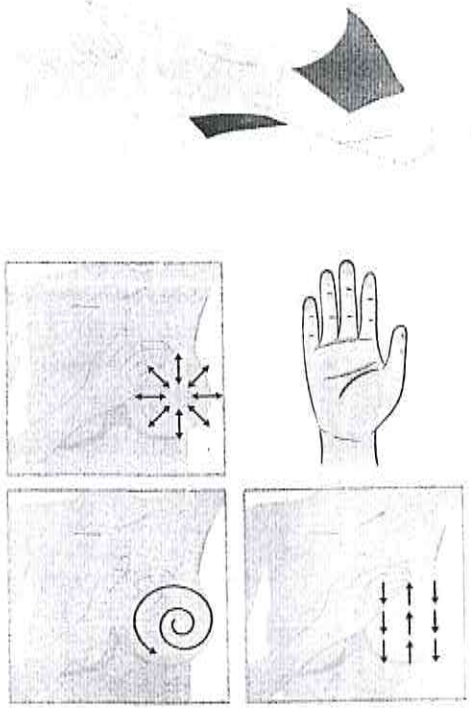
- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

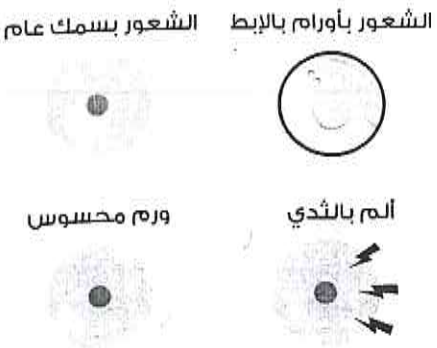
- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

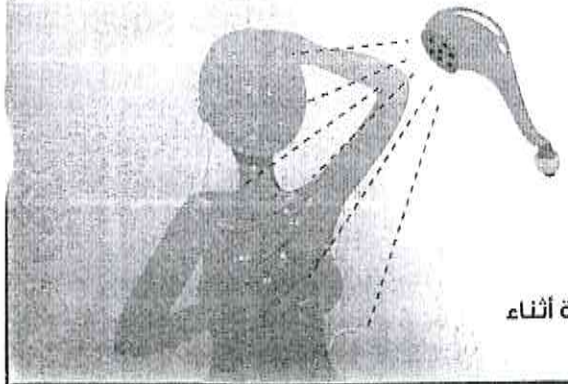


- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.



- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Osseous Structures:
Marked compression deformities/fractures involving the **C7 and T12 vertebral bodies** are noted. The age of these fractures cannot be reliably determined on the current examination. Correlation with prior imaging and clinical history is recommended.

Impression:

1. **Ill-defined right breast mass measuring approximately 33 × 39 mm with diffuse overlying skin thickening and interstitial infiltration**, consistent with the known breast carcinoma.
2. **Multiple enlarged right axillary lymph nodes, including a dominant node measuring approximately 44 × 34 mm, suspicious for metastatic nodal involvement.**
3. Diffuse bronchial wall thickening, compatible with **bronchitis**.
4. **Marked compression fractures/deformities of C7 and T12**, indeterminate in age; further assessment with dedicated spine MRI may be considered, particularly if clinically indicated. No definite visceral metastatic disease identified in the abdomen or pelvis.

Ibrahim

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

No. : 9262
s Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

CT CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST

Exam:
CT scan of the chest, abdomen and pelvis with intravenous contrast.

Clinical History:
Known case of breast carcinoma.

Technique:
Contrast-enhanced CT examination of the chest, abdomen and pelvis was performed with multiplanar reformatted images.

Comparison:
Not Available.

Findings:

Chest:
The right breast shows diffuse skin thickening and increased interstitial soft-tissue density, with an ill-defined mass measuring approximately 33 × 39 mm, consistent with the known breast malignancy.

Multiple enlarged right axillary lymph nodes are identified, suspicious for metastatic nodal involvement, with the largest measuring approximately **44 × 34 mm** and another measuring **13 × 7 mm**.

Small left axillary lymph nodes are noted and appear reactive, with the largest measuring approximately **12 × 6 mm**.

Diffuse bronchial wall thickening is noted, suggestive of **bronchitis**.

No focal pulmonary consolidation or suspicious pulmonary mass/nodule is identified. No pleural or pericardial effusion.

Abdomen and Pelvis:
No significant focal abnormality is identified in the liver, spleen, pancreas, adrenal glands or kidneys.

No significant abdominal or pelvic lymphadenopathy. No ascites.

No gross focal bowel or pelvic organ abnormality is identified.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاليه صلاح الدين فرحات
Request type: مبادره
Hospital no:
Department: صحه مرأه
Referred by: د/ايمان عوني
Nature of specimen: tru-cut biopsy
Clinical diagnosis: Right breast mass

Age:66 years
Sex: female
Sub request type:
Pathology no.:745-2026
Date of result:8/8/2026
Date of biopsy:30/7/2026
I.D. Number:26607271500203

Gross pathology:

multiple gray white cores up to 1cm long each, totally submitted

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin counter-stain. The sections were treated against: Ecadherine-ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing malign growth. Tumor forms files, single dyscohesive cells, sheets, clusters, cords and trabecu infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia w moderate tendency to form tubules and mitosis.

Immunohistochemical Result:

ER: **Weak nuclear staining in 60% of tumor cells (Allred Score 5/8).**
PR: **Weak nuclear staining of 60% of the tumor cells (5/8).**
Her2: **Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (Score 3+)**Her2 Positive
Ki67: **Positive nuclear staining of 70% of tumor cells**

Diagnosis: **Right breast mass, tru-cut biopsy:**
Invasive Mammary Carcinoma (NST), Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Name : Ghalia Salah al-Din Farhat	**Date : 14-09-2026 01:06**
Branch : Dokki	**Medical No. : 461414**
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt	**Ins.Company : تعاقد مستشفيات**

NILE DIAGNOSTIC CENTER

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 60-year-old female with biopsy-proven invasive mammary carcinoma of the right breast. Pre-treatment baseline evaluation. Presents with generalized bony aches. Referred for baseline skeletal staging.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of 99mTc-MDP.

Findings:

- Homogeneous symmetric physiological tracer distribution throughout the axial and appendicular skeleton, including the skull, spine, ribs, sternum, pelvis, and extremities.
- No focal areas of abnormal increased uptake suggestive of osteoblastic or osteolytic metastases.
- Renal excretion is prompt and symmetric.

Impression:

- No scintigraphic evidence of skeletal metastases.
- Baseline study for subsequent comparison.

Dr. Alaa Nagi

MD Nuclear Medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

اسم المريض بالإنجليزية: ah Salah Aldin Farahat	كود المريض: 97711
تاريخ التقرير: 2026/07/30 10:54:08 AM	السن: ٦٠ سنة

Bilateral full field Diagnostic Digital Mammography

Clinical summary: Lumpiness and pain in the right breast felt over a year ago. Areolar and Peri areolar Skin thickening and dimpling in the lower aspect of the breast is clinically noted.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High-resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- **An irregular spiculated mass of high density is noted at the lower central aspect of the breast middle third with associate asymmetric area architectural distortion involving the retroareolar region (findings are best appreciated in the tomosynthesis views).**
- **Another similar smaller mass is noted the UOQ posterior third.**
- **Skin thickening is also noted at the areolar and anterior third of the breast.**
- No suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated **an irregular heterogenous hypoechoic solid mass is noted showing angular margin located at 6 o'clock about 2 cm from the nipple and 1 cm below the skin (index mass). It measured about 3 x 2 x 2.7 cm. it showed ductal extension of 1.5 reaching the nipple.**
- Another **similar smaller mass is noted at the axillary tail about 13 cm from the nipple, measured about 2.6 x 2 x 2.5 cm. two adjuncts rounded pathological IMLNs** at the axillary tail are noted with lost fatty hila.
- Skin thickening is noted reaching 3.5 mm at the areolar and para-areolar region.
- **Multiple pathological axillary lymph nodes are noted at Level I, II, III, mostly showing globular shape and lost fatty hila. The largest seen at level I measured 3 cm in bi-polar dimension ad showed cortical thickening of 13 mm.**

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 5): a multi- centric malignant process involving the right breast with two palpable non-calcified masses , the index mass is seen with ductal extention reaching the nipple, pathological IMLNs and multi-level axillary nodes as described. Biopsy was obtained from the index mass in today sitting.

Left breast (BI-RADS 1) : Normal study .

Recommendations: pathology correlation

Best regards,
Dr. Iman Ewais
Breast Imaging Specialist

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

CT CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST

Exam:
CT scan of the chest, abdomen and pelvis with intravenous contrast.

Clinical History:
Known case of breast carcinoma.

Technique:
Contrast-enhanced CT examination of the chest, abdomen and pelvis was performed with multiplanar reformatted images.

Comparison:
Not Available.

Findings:

Chest:
The right breast shows diffuse skin thickening and increased interstitial soft-tissue density, with an ill-defined mass measuring approximately 33 × 39 mm, consistent with the known breast malignancy.

Multiple enlarged right axillary lymph nodes are identified, suspicious for metastatic nodal involvement, with the largest measuring approximately **44 × 34 mm** and another measuring 13 × 7 **mm**.

Small left axillary lymph nodes are noted and appear reactive, with the largest measuring approximately **12 × 6 mm**.

Diffuse bronchial wall thickening is noted, suggestive of **bronchitis**.

No focal pulmonary consolidation or suspicious pulmonary mass/nodule is identified. No pleural or pericardial effusion.

Abdomen and Pelvis:
No significant focal abnormality is identified in the liver, spleen, pancreas, adrenal glands or kidneys.

No significant abdominal or pelvic lymphadenopathy. No ascites.

No gross focal bowel or pelvic organ abnormality is identified.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Osseous Structures:
Marked compression deformities/fractures involving the **C7 and T12 vertebral bodies** are noted. The age of these fractures cannot be reliably determined on the current examination. Correlation with prior imaging and clinical history is recommended.

Impression:

1. **Ill-defined right breast mass measuring approximately 33 × 39 mm with diffuse overlying skin thickening and interstitial infiltration**, consistent with the known breast carcinoma.
2. **Multiple enlarged right axillary lymph nodes, including a dominant node measuring approximately 44 × 34 mm, suspicious for metastatic nodal involvement.**
3. Diffuse bronchial wall thickening, compatible with **bronchitis.**
4. **Marked compression fractures/deformities of C7 and T12**, indeterminate in age; further assessment with dedicated spine MRI may be considered, particularly if clinically indicated. No definite visceral metastatic disease identified in the abdomen or pelvis.

Ibrahim

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

CT CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST

Exam:
CT scan of the chest, abdomen and pelvis with intravenous contrast.

Clinical History:
Known case of breast carcinoma.

Technique:
Contrast-enhanced CT examination of the chest, abdomen and pelvis was performed with multiplanar reformatted images.

Comparison:
Not Available.

Findings:

Chest:
The right breast shows diffuse skin thickening and increased interstitial soft-tissue density, with an ill-defined mass measuring approximately 33 × 39 mm, consistent with the known breast malignancy.

Multiple enlarged right axillary lymph nodes are identified, suspicious for metastatic nodal involvement, with the largest measuring approximately **44 × 34 mm** and another measuring **13 × 7 mm**.

Small left axillary lymph nodes are noted and appear reactive, with the largest measuring approximately **12 × 6 mm**.

Diffuse bronchial wall thickening is noted, suggestive of **bronchitis**.

No focal pulmonary consolidation or suspicious pulmonary mass/nodule is identified. No pleural or pericardial effusion.

Abdomen and Pelvis:
No significant focal abnormality is identified in the liver, spleen, pancreas, adrenal glands or kidneys.

No significant abdominal or pelvic lymphadenopathy. No ascites.

No gross focal bowel or pelvic organ abnormality is identified.

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Osseous Structures:
Marked compression deformities/fractures involving the **C7 and T12 vertebral bodies** are noted. The age of these fractures cannot be reliably determined on the current examination. Correlation with prior imaging and clinical history is recommended.

Impression:

1. **Ill-defined right breast mass measuring approximately 33 × 39 mm with diffuse overlying skin thickening and interstitial infiltration**, consistent with the known breast carcinoma.
2. **Multiple enlarged right axillary lymph nodes, including a dominant node measuring approximately 44 × 34 mm, suspicious for metastatic nodal involvement.**
3. Diffuse bronchial wall thickening, compatible with **bronchitis**.
4. **Marked compression fractures/deformities of C7 and T12**, indeterminate in age; further assessment with dedicated spine MRI may be considered, particularly if clinically indicated. No definite visceral metastatic disease identified in the abdomen or pelvis.

Ibrahim

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

CT CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST

Exam:
CT scan of the chest, abdomen and pelvis with intravenous contrast.

Clinical History:
Known case of breast carcinoma.

Technique:
Contrast-enhanced CT examination of the chest, abdomen and pelvis was performed with multiplanar reformatted images.

Comparison:
Not Available.

Findings:

Chest:
The right breast shows diffuse skin thickening and increased interstitial soft-tissue density, with an ill-defined mass measuring approximately 33 × 39 mm, consistent with the known breast malignancy.

Multiple enlarged right axillary lymph nodes are identified, suspicious for metastatic nodal involvement, with the largest measuring approximately **44 × 34 mm** and another measuring **13 × 7 mm**.

Small left axillary lymph nodes are noted and appear reactive, with the largest measuring approximately **12 × 6 mm**.

Diffuse bronchial wall thickening is noted, suggestive of **bronchitis**.

No focal pulmonary consolidation or suspicious pulmonary mass/nodule is identified. No pleural or pericardial effusion.

Abdomen and Pelvis:
No significant focal abnormality is identified in the liver, spleen, pancreas, adrenal glands or kidneys.

No significant abdominal or pelvic lymphadenopathy. No ascites.

No gross focal bowel or pelvic organ abnormality is identified.

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : 9262
Patient's Name: Ghalia Salah al-Din Farhat
Date: 2026-09-28
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Osseous Structures:
Marked compression deformities/fractures involving the **C7 and T12 vertebral bodies** are noted. The age of these fractures cannot be reliably determined on the current examination. Correlation with prior imaging and clinical history is recommended.

Impression:

1. **Ill-defined right breast mass measuring approximately 33 × 39 mm with diffuse overlying skin thickening and interstitial infiltration**, consistent with the known breast carcinoma.
2. **Multiple enlarged right axillary lymph nodes, including a dominant node measuring approximately 44 × 34 mm, suspicious for metastatic nodal involvement.**
3. Diffuse bronchial wall thickening, compatible with **bronchitis.**
4. **Marked compression fractures/deformities of C7 and T12**, indeterminate in age; further assessment with dedicated spine MRI may be considered, particularly if clinically indicated. No definite visceral metastatic disease identified in the abdomen or pelvis.

Ibrahim

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

10/13/2026

MDT FORM

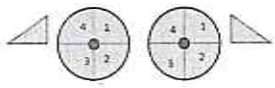
Name:	غاليه مصطفى الدين فرحات	**MRN:**	13650
Age:	60 Y	**ID:**	26607271500203
Menopausal Sta	POST	**Phone:***	01124887003
NRS SCORE:	PS1	**Marital Status:**	M
BMI:	30	**Family History:**	+VE
Gender			
CO Morbidity:	DM	**Reason Of MDT:**	NEW
Surgical History:*	NAD	**ECOG Performance Status**	○ 0 ◉ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: IDC GIII

ER: 5/8 **PR:** 5/8 **HER2:** +3 **KI67:** 70

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

History:

Sonomammography:
RT BREAST MASS WITH SKIN THICKNESS AND EDEMA
MULTIPLE RT AXILLARY LNS

Biomarker/Molecular

Mets Workup:
CT CAP C7 ,T12 MARKED DEFORMITIES
BONE SCAN FREE

Recommendations:
FOR NACT, MRI DORSAL AND CERVICAL WITH CONTRAST, THEN RT MRM

Clinical Staging:

Pathological Staging:

MDT Outcome & Plan
Portacath insertion
TCHP x 6 cycles
then RT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د خالد عبد العزيز	د محمد تيراوي		